

Enfrentamiento inicial de la fiebre en el viajero que regresa

Las tres preguntas que ordenan el caso · Los diagnósticos que matan y los que se contagian · Qué pedir el primer día

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: B — Sección VII (Otras zoonosis e infecciones en viajeros)

Glosario de siglas: ITS: infecciones de transmisión sexual · PDR: prueba de diagnóstico rápido · FHV: fiebre hemorrágica viral · MERS: síndrome respiratorio de Oriente Medio · ISP: Instituto de Salud Pública · SEREMI: Secretaría Regional Ministerial de Salud · EPP: elementos de protección personal · LDH: lactato deshidrogenasa · PCR: proteína C reactiva o reacción de polimerasa en cadena según contexto · TC: tomografía computada.

Alcance y fuentes. Enfrentamiento sindromático inicial para el internista de urgencia y de sala. Basado en el *CDC Yellow Book*, las recomendaciones de la OMS, las guías IDSA y los datos de la red GeoSentinel. **El manejo específico de malaria, arbovirosis, leptospirosis y demás entidades se desarrolla en los documentos respectivos de esta sección. Toda sospecha de enfermedad de notificación obligatoria o de importancia internacional debe comunicarse a la SEREMI de Salud: verificar la normativa vigente del MINSAL.**

Índice

1. El principio que ordena el tema
2. Las tres preguntas iniciales
3. Historia clínica dirigida
4. Períodos de incubación como filtro diagnóstico
5. Causas por destino
6. Causas por síndrome acompañante
7. Estudio de primera línea
8. Los diagnósticos que no se pueden perder
9. Cuándo aislar y cuándo notificar
10. Errores frecuentes
11. Perlas de alto rendimiento
12. Bibliografía esencial

1. El principio que ordena el tema

En el viajero febril **la epidemiología es el examen complementario más potente**: destino, fechas, actividades, exposiciones y profilaxis reducen el diferencial más que cualquier examen de sangre.

Y, sin embargo, dos advertencias mantienen los pies en la tierra:

- **La causa más frecuente de fiebre en el viajero sigue siendo una infección común y cosmopolita** (virosis respiratoria, influenza, COVID-19, infección urinaria, gastroenteritis, neumonía). No hay que exotizar.
- **Pero la causa más urgente es la malaria por *Plasmodium falciparum*, que mata en días.** Por eso la regla es absoluta:

REGLA DE ORO. Todo viajero febril procedente de una zona con malaria tiene malaria hasta que se demuestre lo contrario. Se pide gota gruesa/frotis o prueba de diagnóstico rápido el mismo día, y se repite si es negativa.

2. Las tres preguntas iniciales

1. **¿Puede ser malaria?** -> Zona endémica, cualquier intervalo desde 7 días hasta meses (años en *P. vivax* y *P. ovale*). **Examen urgente.**
2. **¿Está grave o se está deteriorando?** -> Hipotensión, alteración de conciencia, ictericia, sangrado, hipoxemia, oliguria, acidosis. **Reanimar y hospitalizar.**

3. ¿Es **transmisible** y **requiere aislamiento**? -> Fiebre hemorrágica viral, sarampión, tuberculosis, influenza/COVID-19, MERS, difteria, meningococo. **Aislar antes de continuar el estudio.**

Solo después de estas tres se despliega el diferencial completo.

3. Historia clínica dirigida

Dominio	Qué preguntar
Itinerario detallado	Países y zonas (urbana/rural, altura, selva), fechas exactas de ida y regreso, escalas
Cronología	Fecha de inicio de los síntomas en relación con el viaje (define el período de incubación)
Profilaxis	Quimioprofilaxis antimalárica (cuál, adherencia, si la completó al regresar), vacunas previas al viaje (fiebre amarilla, hepatitis A/B, fiebre tifoidea, rabia, encefalitis japonesa)
Alimentos y agua	Agua no potable, hielo, lácteos no pasteurizados (brucelosis), carne cruda o mal cocida de cerdo/jabalí (triquinosis), pescado crudo, verduras crudas
Agua dulce	Baño o inmersión en agua dulce: esquistosomiasis, leptospirosis
Vectores	Picaduras de mosquito (día: <i>Aedes</i> -> dengue/zika/chikungunya; noche: <i>Anopheles</i> -> malaria), garrapatas (rickettsiosis), moscas (tripanosomiasis africana), vinchucas (Chagas)
Animales	Mordeduras y arañazos (rabia), contacto con ganado (brucelosis, fiebre Q), aves, murciélagos y cuevas (histoplasmosis), roedores (leptospirosis, hantavirus)
Contacto sexual	Nuevas parejas, sexo sin protección -> ITS, VIH agudo, hepatitis virales, sífilis
Contacto con enfermos	Personas febriles, funerales, hospitales, campos de refugiados
Actividades	Espeleología, safari, trabajo en salud, ayuda humanitaria, visita a familiares y amigos (grupo VFR , de mayor riesgo por menor uso de profilaxis)
Antecedentes	Inmunosupresión, asplenia, embarazo, comorbilidad, fármacos

Callout. El grupo *VFR* (*visiting friends and relatives*)** —migrantes que regresan a su país de origen— tiene el **mayor riesgo de malaria grave**, porque suele viajar sin consulta previa, sin profilaxis y a zonas rurales, y porque la inmunidad parcial adquirida en la infancia se pierde.

4. Períodos de incubación como filtro diagnóstico

Incubación	Entidades
< 7 días (corta)	Dengue, chikungunya, zika , influenza y otros virus respiratorios, COVID-19, gastroenteritis bacteriana, leptospirosis , rickettsiosis, fiebre entérica precoz, meningococcemia, fiebres hemorrágicas virales
7-21 días (intermedia)	Malaria, fiebre tifoidea/paratifoidea , leptospirosis, brucelosis , rickettsiosis, VIH agudo , hepatitis A y E, tripanosomiasis africana, esquistosomiasis aguda (síndrome de Katayama), fiebres hemorrágicas
> 21 días (larga)	Malaria (especialmente <i>P. vivax</i> y <i>P. ovale</i>, meses a años) , tuberculosis, brucelosis, absceso hepático amebiano, leishmaniasis visceral , hepatitis B, VIH , filariasis, histoplasmosis, esquistosomiasis crónica, fiebre Q

Punto de alto rendimiento. Una fiebre que comienza más de 21 días después del regreso descarta prácticamente el dengue, el chikungunya, el zika y las fiebres hemorrágicas virales —pero **no** descarta malaria, tifoidea, brucelosis, TB ni absceso amebiano.

5. Causas por destino

Región	Considerar en primer lugar
África subsahariana	Malaria por <i>P. falciparum</i> (la más grave), rickettsiosis africana por garrapata, esquistosomiasis, fiebre tifoidea, VIH agudo, tripanosomiasis, FHV (Ébola, Lassa, Marburgo) en brotes

Región	Considerar en primer lugar
Sudeste asiático	Dengue , chikungunya, malaria, fiebre tifoidea, leptospirosis , tifus de los matorrales (<i>Orientia tsutsugamushi</i>), hepatitis A
Sur de Asia (India, Nepal, Pakistán)	Fiebre tifoidea y paratifoidea (frecuentemente resistentes) , dengue, malaria, hepatitis A y E
América Latina y el Caribe	Dengue , chikungunya, zika, malaria (Amazonía), leptospirosis , enfermedad de Chagas , fiebre tifoidea, hepatitis A, histoplasmosis, fiebre amarilla en zonas selváticas
Medio Oriente / Península Arábiga	Brucelosis (lácteos no pasteurizados), MERS-CoV (contacto con camellos), fiebre tifoidea
Oceanía y Pacífico	Dengue, zika, chikungunya, leptospirosis
Regiones templadas (Europa, Norteamérica)	Causas cosmopolitas: influenza, COVID-19, neumonía, ITS, mononucleosis; enfermedad de Lyme en zonas endémicas

Contexto chileno. Chile continental es libre de malaria autóctona y no tiene transmisión autóctona sostenida de dengue en el territorio continental; Isla de Pascua (Rapa Nui) sí tiene *Aedes aegypti* y ha presentado brotes de dengue, y se ha detectado *Aedes aegypti* en el extremo norte del país, lo que mantiene la vigilancia activa. La enfermedad de Chagas es endémica entre las regiones de Arica y Parinacota y O'Higgins. Verificar la situación epidemiológica y las alertas vigentes del MINSAL y del ISP, que cambian año a año.

6. Causas por síndrome acompañante

Síndrome	Diagnósticos a considerar
Fiebre sin foco	Malaria , fiebre tifoidea, dengue, rickettsiosis, leptospirosis, VIH agudo, brucelosis
Fiebre + exantema	Dengue , chikungunya , zika , sarampión , rickettsiosis (escara de inoculación), VIH agudo , sífilis secundaria, meningococcemia, fiebre tifoidea (roséola)
Fiebre + diarrea	Gastroenteritis bacteriana (<i>Campylobacter</i> , <i>Salmonella</i> , <i>Shigella</i>), fiebre tifoidea , amebiasis, malaria (puede dar diarrea)
Fiebre + ictericia	Malaria grave , leptospirosis (síndrome de Weil) , hepatitis A/E, fiebre amarilla , colangitis, FHV
Fiebre + síntomas respiratorios	Influenza, COVID-19, neumonía, tuberculosis , histoplasmosis (cuevas), legionelosis (hoteles, aire acondicionado), hantavirus (roedores; relevante en Chile), MERS
Fiebre + compromiso neurológico	Malaria cerebral , meningococo, encefalitis japonesa, virus del Nilo Occidental, rabia, tripanosomiasis, TB meníngea, neurocisticercosis
Fiebre + eosinofilia	Esquistosomiasis aguda (Katayama) , triquinosis , estrongiloidiasis, filariasis, larva migrans visceral, fasciolosis, reacción a fármacos
Fiebre + esplenomegalia	Malaria, leishmaniasis visceral , brucelosis, fiebre tifoidea, VEB/CMV, tripanosomiasis
Fiebre + sangrado o trombocitopenia	Dengue grave , malaria, leptospirosis, FHV , meningococcemia, rickettsiosis, hantavirus
Fiebre + adenopatías	VIH agudo, VEB/CMV, tuberculosis, leishmaniasis, tripanosomiasis, sífilis, peste (rara)
Fiebre + úlcera o escara cutánea	Rickettsiosis (escara negra) , tripanosomiasis (chancro), leishmaniasis cutánea, carbunco

7. Estudio de primera línea

Siempre, el primer día:

- Gota gruesa y frotis fino (o PDR de malaria) si hubo exposición a zona endémica. Si es negativa y la sospecha persiste, repetir a las 12-24 horas y una tercera vez: una sola muestra negativa no descarta.
- Hemograma con recuento diferencial y plaquetas (trombocitopenia: malaria, dengue, leptospirosis, rickettsiosis; leucopenia con linfopenia: dengue, tifoidea; eosinofilia: helmintos).
- PCR/VHS, perfil bioquímico y hepático, creatinina y electrolitos, glicemia, **LDH**, orina completa.
- Dos sets de hemocultivos (rendimiento en fiebre tifoidea, brucelosis, bacteriemias).

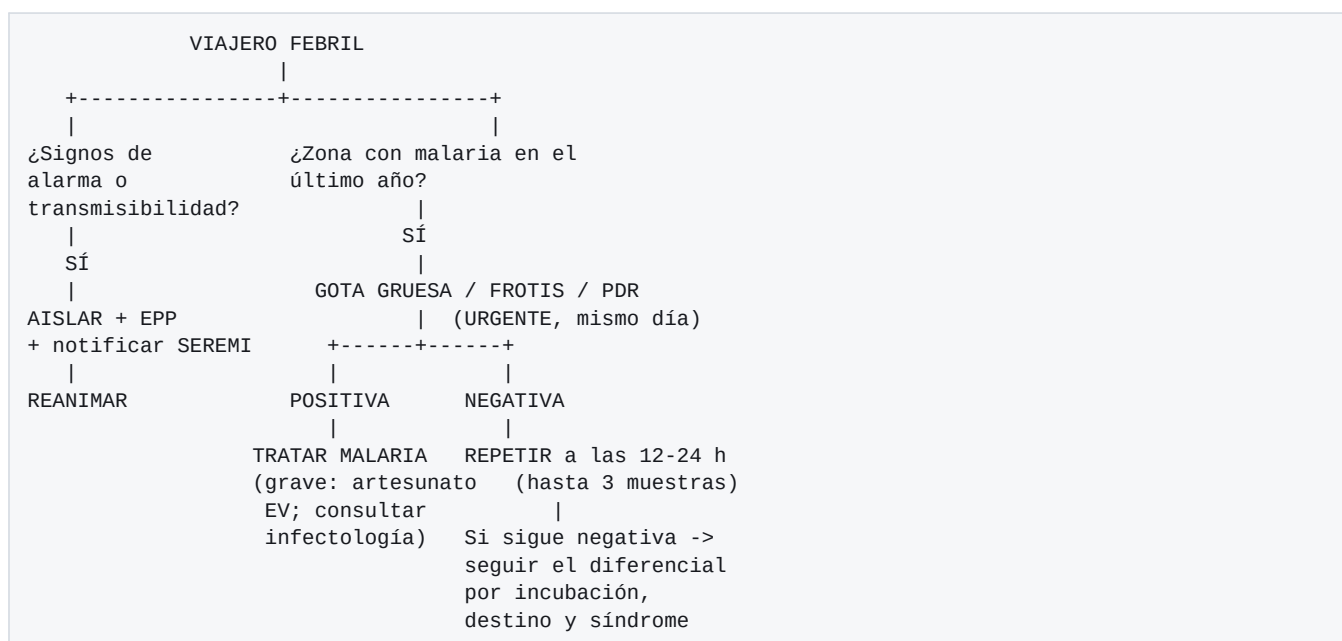
- **Test de VIH** (con consentimiento; el síndrome retroviral agudo se pasa por alto con frecuencia).
- **Panel respiratorio / PCR de influenza y SARS-CoV-2** según clínica.
- **Radiografía de tórax.**
- Test de embarazo cuando corresponda.

Dirigidos, según la sospecha:

- **Serologías/PCR de arbovirus** (dengue: **NS1 y PCR en la fase virémica, IgM desde el día 5**; zika, chikungunya).
- **Serología y PCR de leptospirosis**, con la limitación de que la serología requiere muestra pareada.
- **Aglutinaciones y hemocultivo para *Brucella*** (avisar al laboratorio: crecimiento lento).
- **Coprocultivo, parasitológico seriado, toxina de *C. difficile*.**
- **Baciloscopías y Xpert MTB/RIF** si hay tos prolongada o factores de riesgo.
- **Serología de rickettsias** (pareada), **serología de esquistosoma**, **serología de *Trichinella*.**
- **Ecografía o TC de abdomen** si hay dolor en hipocondrio derecho o hepatomegalia (**absceso hepático amebiano**).
- **Fondo de ojo y punción lumbar** si hay compromiso neurológico (tras imagen cuando esté indicada).

Callout. Guardar suero de la fase aguda y congelarlo. Muchas etiologías se confirman con **serología pareada** a las 2-4 semanas, y sin la muestra inicial el diagnóstico queda perdido para siempre.

8. Los diagnósticos que no se pueden perder



Los cinco a tener siempre presentes:

1. **Malaria por *P. falciparum*** — mortalidad alta y evitable; el retraso diagnóstico es el principal determinante. **Malaria grave = artesunato endovenoso**, manejo en unidad de mayor complejidad y consulta a infectología.
2. **Fiebre tifoidea** — hemocultivos, riesgo de perforación intestinal; **resistencia creciente a fluoroquinolonas** en el sur de Asia.
3. **Dengue grave** — la fase crítica es **la defervescencia (días 4-6)**, con extravasación de plasma. **No usar AINE ni aspirina**; el manejo es de fluidos.
4. **Leptospirosis** — síndrome de Weil con ictericia, falla renal y hemorragia pulmonar; responde a **doxiciclina o penicilina/ceftriaxona**, y el tratamiento empírico precoz salva vidas.
5. **Fiebres hemorrágicas virales y otras enfermedades de importancia internacional** — raras, pero exigen **aislamiento inmediato y notificación**.

Y dos que se olvidan pese a ser tratables: el **absceso hepático amebiano** (fiebre + dolor en hipocondrio derecho semanas o meses después) y la **tuberculosis**.

9. Cuándo aislar y cuándo notificar

Aislar de entrada (antes de tener el diagnóstico):

- **Sospecha de fiebre hemorrágica viral** (África subsahariana, contacto con enfermos o funerales, sangrado): **aislamiento estricto con EPP completo, sala individual, mínimo personal expuesto, contacto inmediato con infectología y con la autoridad sanitaria. No manipular muestras sin coordinación previa con el laboratorio y el ISP.**
- **Sarampión** (exantema + fiebre + catarro + conjuntivitis, no vacunado): **aislamiento aéreo.**
- **Tuberculosis pulmonar sospechada:** **aislamiento aéreo.**
- **Influenza, COVID-19, MERS:** precauciones de gotitas ± aéreas según norma.
- **Difteria, meningococo:** precauciones de gotitas.
- **Diarrea infecciosa:** precauciones de contacto.

Notificar a la SEREMI de Salud (enfermedades de notificación obligatoria — la lista está definida por decreto y debe verificarse en su versión vigente): entre otras, **fiebre tifoidea y paratifoidea, cólera, sarampión, rubéola, enfermedad meningocócica, tuberculosis, hantavirus, dengue, fiebre amarilla, chikungunya, zika, malaria, leptospirosis, brucelosis, triquinosis, hidatidosis, enfermedad de Chagas, rabia, listeriosis, y toda sospecha de evento de importancia para la salud pública internacional** conforme al **Reglamento Sanitario Internacional.**

Callout. Ante la duda, **notificar y consultar:** la notificación no tiene costo clínico para el paciente y permite la investigación de contactos y de la fuente. La confirmación de la mayoría de estas etiologías se realiza en el **ISP** como laboratorio nacional de referencia.

10. Errores frecuentes

1. **No pedir gota gruesa** en un viajero febril procedente de zona endémica, o **descartar malaria con una sola muestra negativa.**
2. Asumir que la **quimioprofilaxis correctamente tomada descarta la malaria:** la reduce mucho, pero no la excluye.
3. **No preguntar el itinerario detallado** (zona rural vs urbana, actividades, fechas).
4. **No calcular el período de incubación,** que es un filtro diagnóstico de enorme rendimiento.
5. **Exotizar:** olvidar que la mayoría de las fiebres son causas comunes (influenza, COVID-19, ITU, neumonía).
6. Al revés: **atribuir todo a un "virus"** y no descartar malaria ni tifoidea.
7. **No tomar hemocultivos antes de los antibióticos.**
8. **Indicar AINE o aspirina** en un posible dengue.
9. **No guardar suero de fase aguda** para serología pareada.
10. **No aislar precozmente** una sospecha de sarampión, TB o fiebre hemorrágica viral.
11. **No ofrecer test de VIH** ante un síndrome febril con exantema y linfadenopatía tras contacto sexual de riesgo.
12. **No notificar** a la autoridad sanitaria.
13. Olvidar el **absceso hepático amebiano** y la **tuberculosis** en la fiebre de aparición tardía.

11. Perlas de alto rendimiento

- **Todo viajero febril de zona endémica tiene malaria hasta que se demuestre lo contrario;** gota gruesa el mismo día y repetir hasta tres veces.
- **Fiebre que comienza > 21 días después del regreso descarta dengue, chikungunya, zika y FHV,** pero no malaria, tifoidea, brucelosis, TB ni absceso amebiano.
- **Malaria por *P. vivax* y *P. ovale* puede debutar meses o años después** (hipnozoítos).
- **Fiebre + ictericia + falla renal tras contacto con agua dulce -> leptospirosis.**
- **Fiebre + escara negra de inoculación -> rickettsiosis** (tratamiento: doxiciclina, empírico).
- **Fiebre + eosinofilia tras baño en agua dulce en África -> síndrome de Katayama (esquistosomiasis aguda).**
- **Dengue: la fase crítica es cuando baja la fiebre,** no cuando está alta.
- **El grupo VFR es el de mayor riesgo de malaria grave.**
- **Malaria grave: artesunato endovenoso,** con consulta a infectología y manejo en unidad crítica.

- **Guardar suero de la fase aguda:** sin él no hay serología pareada.
 - **Ante sospecha de fiebre hemorrágica viral:** aislar primero, estudiar después, y avisar al laboratorio, a infectología y a la autoridad sanitaria antes de tomar muestras.
-

12. Bibliografía esencial

1. **Centers for Disease Control and Prevention.** *CDC Yellow Book: Health Information for International Travel* (edición vigente), capítulo "Fever in the Returned Traveler".
 2. **Freedman DO, et al. (GeoSentinel Surveillance Network).** *Spectrum of disease and relation to place of exposure among ill returned travelers.* N Engl J Med 2006;354:119-130; y actualizaciones posteriores de la red GeoSentinel.
 3. **World Health Organization.** *Guidelines for the Treatment of Malaria* (versión vigente) y *International Health Regulations* (2005).
 4. **Thwaites GE, Day NP.** *Approach to Fever in the Returning Traveler.* N Engl J Med 2017;376:548-560.
 5. **MINSAL, Chile.** Decreto de **enfermedades de notificación obligatoria** y circulares de vigilancia epidemiológica (dengue, malaria, Chagas, hantavirus, leptospirosis). **Verificar la versión vigente.**
 6. **Instituto de Salud Pública de Chile (ISP).** Laboratorio nacional de referencia: algoritmos de confirmación y condiciones de envío de muestras.
 7. **UpToDate.** Temas: *Evaluation of fever in the returning traveler, Approach to the patient with eosinophilia and travel, Prevention of malaria infection in travelers.*
 8. **MKSAP (American College of Physicians).** Sección de Enfermedades Infecciosas: infecciones en el viajero.
-

Documento de estudio para la rotación de Infectología. No reemplaza el juicio clínico ni los protocolos institucionales vigentes de la Red de Salud UC CHRISTUS. La situación epidemiológica y las listas de notificación obligatoria cambian: verificar siempre las alertas y normas vigentes del MINSAL y del ISP.